

제 2장 내분비 이상

2절. 여성의 일차진료와 갑상샘 질환

1. 갑상선 기능 저하증

1) 개술

- ① **갑상선 호르몬 감소**로 인해 발생하는 일련의 증상을 주소로 하는 질환
- ② 한의학 관련 병증: 浮腫, 虛勞, 行遲, 語遲, 結陽, 解顱 상
- ③ [빈도] 여성의 2%에서 발병, 여성이 남성보다 5-10배 많음
65세 이상 여성의 자가면역 갑상선염은 15%에서 발병
- ④ [원인] 불명이거나 자가면역에 의해 발생
- ⑤ [위험인자] 나이, 다른 자가면역질환, 갑상선기능항진증의 용해성 치료
+) 항진증의 치료를 위해 기능을 저하시키면 2차적으로 저하증으로 이어짐.
+) 갑상선염이 저하증의 90%의 원인이 됨

※ 하시모토 갑상선염 (교과서 X)

= 만성 갑상선염 = 임파구성 갑상선염 = 자가면역성 갑상선염

- 갑상선의 확산성(미만성) 임파구의 침윤/섬유화
- 여포세포의 호산상 변화
- 임상적으로 가장 흔하게는 무증상이거나 갑상선기능저하증으로 나타남
- 갑상선기능저하증의 90%

2) 갑상선기능저하증 증상

① 일반증상

- 寒不耐性, 변비, 수근관증후군, 피부건조, 탈모, 졸음, 체중증가, 눈 주위와 사지의 부종, 서맥

② 생식기능 이상

- 병의 초기에는 월경과다가 존재 병이 진행됨에 따라 **무월경** 유발
- 배란장애를 유발하여 난임을 초래, 월경전증후군이 심해지기도 함
- TSH 결핍으로 인한 TRH 증가로 프로락틴 분비가 늘어 유즙분비증 발생
+) 프로락틴 증가로 인한 P억제 -> 황체기 장애로 이어짐
- SHBG(성호르몬 결합 글로불린)의 농도가 떨어지게 됨
+) SHBG가 떨어지면 유리 T가 증가함에 따라 E1/E2 음성 피드백 정상 X

3) 갑상선기능저하증의 원인별 분류

일차성 갑상선기능저하증	갑상선종	
	자가면역성	하시모토
		무통성 갑상선염
	갑상선 호르몬 생산 장애	요오드 결핍
		선천성 갑상선호르몬 생산 장애
		항갑상선제 복용
	갑상선 침윤성 병변	아밀로이드증, 경피증
뇌하수체성 갑상선기능저하증	아급성 갑상선염(일과성)	
	뇌하수체 종양	
	취한증후군	
시상하부성 갑상선기능저하증	수술, 방사선치료, 외상	
	종양	
	외상	
	침윤성 병변	
	갑상선종이 없는 경우	

전신성 갑상선호르몬내성	위축성 자가면역성 갑상선염
	방사성 요오드 치료(그레이브스병)
	수술(갑상선 종양, 그레이브스병)

4) 갑상선기능저하증 진단

① TSH 증가, free T4 감소

② 항티로글로블린 항체(TgAb) 증가 (정상범위: 0-0.3IU/ml)

③ 항미소체 항체(antimicrosomal Ab) 양성 (정상범위: 0-0.3IU/ml)

5) 서양의학적 진단 & 치료

- 증상이 없더라도 TSH가 상승되어 있고 갑상선 항체 검사가 양성인 경우
→ 매년 5%의 갑상선 기능 저하증이 발생함 따라서 치료 개시
- 단지 TSH만 상승된 경우에는 매년 3%의 저하증이 발생
- Levothyroxine을 사용함(대부분 T4로 분비 말초에서 T3로 전환)
-

6) 갑상선기능저하증 환자에서의 부인과 수술

- 과거 방사성요오드 치료나 갑상선 절제치료를 받은 후 갑상선기능저하증이 생겼으나 치료되지 않는 경우는 치료를 시작할 때까지 부인과수술 연기
- 응급상황이나 심한 점액수종 시에는 일단 수술을 시행한 후에 약물치료를 시행

7) 갑상선기능저하증의 한의학적 관리

右歸飲, 補中益氣湯, 八味地黃湯, 十全大補湯 등을 응용함

2. 갑상선기능항진증

1) 개술

- ① **갑상선 호르몬 과다**에 의한 증상을 나타내는 질환
- ② 한의학 관련 병증: 癭病, 癭瘤, 消渴, 驚悸, 怔忡, 顴眼突出, 免眼, 煩燥
- ③ [빈도] 여성의 2%가 일생 중 걸릴 수 있으며,
대부분 가임기 여성이 남성보다 3배 정도 많음
- ④ 그레이브스병에 의한 경우 흔함

※ 그레이브스병(Graves disease)

- 갑상선기능항진증의 가장 흔한 원인이 되는 자가면역질환
- 전 연령층에서 발생하지만 85%가 20-60세 사이
- 10세 미만 어린이나 70이상 노인에게는 드물다
- 남성보다 여성에서 3-8배 많이 발생
- 전형적인 증상으로 안구돌출증, 갑상선종대, 갑상선기능항진증 등의 증상

2) 갑상선기능항진증의 증상★

- ① 그레이브스병의 임상적 세 징후 : 안구돌출증, 갑상선 종대, 갑상선기능항진증
 - ② 일반증상 : 신경과민, 배변증가, 열 불내성, 신경질, 심계항진, 떨림 체중감소, 식욕증가, 피로
 - ③ 생식기능 : 대부분은 정상월경을 보이고 임신 가능이지만, 심한 경우 체중감소, 월경불순, 무월경
- +) 갑상선 기능항진증 무월경의 원인(참고)
- T3, T4증가 -> SHBG 합성 증가 -> T 및 안드로스텐디온 증가 -> E2 증가 -> 부적절한 LH 증가에 따른 무배란 주기 발생

3) 갑상선기능항진증 진단

- ① **TSH 감소, 혈청 총 T3/4 증가, 혈청 유리 T3/4 증가**
- ② 항미소체 항체 양성
- ③ TSI (갑상선자극 면역글로불린) 양성
- ④ TBII (TSH 결합억제 면역글로불린) 양성

4) 서양의학적 치료

- ① 약물치료(항갑상선제, 초기치료) : 6-24개월 지속
 - Propylthiouracil(PTU) : 태반 통과 X (임산부 PTU 사용)
 - Methimazole : 태반 통과 O (1차 선택 약물, 임산부는 금기)
- ② 방사성 요오드 치료 : 7-80%에서 완치
 - 임신 중이나 수유중인 여성에서 절대적 금기
 - 오래 사용 X 장기 사용시 갑상선기능저하증으로 이어짐(50%)
- ③ 수술요법 : 갑상선 부분절제
 - 약물치료에 실패하거나 항갑상선제에 과민한 경우

5) 갑상선기능항진증의 한의학적 관리

- +) 갑상선기능항진증은 기본적으로 음허, 화, 열의 개념으로 바라봄
- **육미지황탕, 단치소요산, 십육미유기음, 용담사간탕**
 - 안질환 -> 석결명산
 - 갑상선 종대 -> 해조옥호탕(난소 낭종에도 사용되는 처방)

6) 갑상선 기능 항진증 예후

- ① 약물치료 후 재발율 50% 이상
- ② 방사성 요오드 치료 후 50% 이상에서 갑상선기능저하증 발생
 - 평생 갑상선호르몬 대체요법 시행
- ③ 갑상선 자극항체와 임신의 영향
 - 그레이브스형 환자가 임신하면 수태아 - 신생아 갑상선기능항진증 야기
 - 자연유산, 사산, 태아기형 증가할 수 있다

3. 산후갑상선기능장애

1) 발생 시기 및 빈도

- ① 분만 후 1 - 8개월에 발생
- ② 산후 우울증으로 생각하므로 진단 어려움
- ③ 산후 약 5%에서 발생 (한국은 8.1% 세계 3-16%) 하며,
25%는 영구적 갑상샘기능저하를 보임

2) 원인

Microsomal antibody에 의한 갑상선염(으로 추정)

-> 갑상선 자가면역항체가 있는 상태에서 산후에 면역체계가 재가동

3) 임상양상

- 산후 6-12주에 우울, 피로, 심계항진 등
- 드물게 산후정신병의 원인

※ 2단계가 존재함

- ① Thyrotoxic(갑상선 중독) phase : 4%에서 생김, 산후 1-4개월에 발생
- ② Hypothyroid phase(기능저하) : 2~5%에서 생기며, 산후 4-8개월에 발생
 - 일과성 갑상선 기능항진에서 시작해 기능저하증으로 진행되는 양식
 - 약 25%에서 이러한 과정을 겪음
 - 30% 이상은 기능의 항진, 저하의 양식으로 나타남

4) 서양의학적 치료

- ① 갑상선기능 저하기에 발견되어 증상이 있을 경우
 - 6-12개월 동안 T4 투여
 - 약 25%에서 영구적인 갑상선기능저하를 보이므로 정기적인 TSH 검사
- ② 갑상선기능 항진기(초기)에 진단된 경우
 - 항갑상선 치료가 꼭 필요하지 않음
 - 증상 경감 위해 베타아드레날린 차단제 사용 가능

5) 한의학적 관리

- 산후 기울증, 산후 허로, 산후 부종의 범주로 본다
- 산후 기력저하나 우울증 소견 보이는 여성의 진단 가능성 높으며,
일반적인 치료로 호전이 없을 경우에는 갑상선 기능에 대한 검사가 필요
- 이음전, 안신생화탕, 보허탕, 군령탕 등 산후처방을 증상에 따라 활용

제 3장 성 발달과 성기능 장애

1절. 성 발달

1. 정상적인 성의 발달

- ① 유전적, 체질적, 신체적인 생물적 요인
- ② 부모, 스승, 사회로부터 받는 교육적, 사회적 요인
- ③ 종교, 철학, 윤리 도덕 및 문화적 요인
 - 위와 같은 여러 요인이 복합적 영향을 미침

2. 정신성

- 성과 인격의 의미를 동시에 지니는 것
- 성 발달을 성의 감정이나 행동에 국한하지 않고 인격 발달의 한 양상으로 봄

3. 소아기의 성 학습

- 대부분 성 학습은 부모가 의식하지 못한 채로 소아의 타고난 신체적 성에 따른 부모의 양육 태도에 영향을 받음
- 임계기
 - : 성장과정 중 인체 기관이 특정 자극에 민감한 시기
 - : 남녀의 성 역할에 결정적인 시기가 될 수 있음

4. 정신적인 요인

- ① 성주체성 (= 생물학적인 성징)
 - 염색체, 외부생식기, 호르몬 구성, 생식선, 2차성징
- ② 정신성 주체성
 - 남성다움이나 여성다움과 관계된 행동의 사회적이고도 심리적인 측면을 의미
 - 정상적으로 생물학적 성(sex)과 사회적 성(gender)은 일치
 - 자신의 성에 적절한 역할을 달성하게 되는 주된 요인은 학습
- ③ 성 지남력
 - 성충동의 대상이 누구인가 하는 것 (이성적, 동성적, 양성적)
- ④ 성 행위
 - 정신 생리적 경험으로 정신성적 발달,
: 성에 대한 심리적 태도, 성적 파트너에 대한 태도가
성 반응의 생리와 연관되어 영향을 미침

5. 인간의 정상적인 성 반응주기

※ Masters&Johnson의 성반응 4단계

1단계 - 욕구기

- 성적공상이나 성행위에 대한 욕구가 특징적이다
- 생리적 변화가 특징적인 다른 단계와 구분된다

2단계 - 흥분기

- 심리적/생리적 자극에 의해 성적 흥분이 발생
- 남성에서는 음경발기, 여성에서는 질내윤활이 특징
- 남녀 모두 유두 발기, 음핵 커짐, 소음순은 정맥울혈로 두터워짐
- 초기 흥분은 수분 ~ 수시간 지속
- 자극에 따라 남성 고환은 50% 커지고, 여성 유방은 25% 증가
- 음경/질/소음순은 붉어지고, 복부/흉부/얼굴/목에서 성 홍조 나타남

3단계 - 절정기

- 성적 긴장이 해소되고 회음부 근육/골반 생식기가 주기적으로 수축하면서 쾌감이 최고조에 도달
- : 남성의 경우 사정 여성의 경우 자궁의 지속적인 강렬한 수축이 나타남
- 전신근육 수축, 호흡수/혈압 증가가 3~25초 동안 지속, 의식 흐림

4단계 - 해소기

- 혈류량, 근육 긴장도, 성충동 등이 점차 완화됨
- 절정감을 성취하지 못했을 경우에 해소에 2~6시간이 걸리고 짜증과 불편감 동반 가능 (반복 시 골반울혈증후군)
- 남성 : 절정감 후에 불응기가 있음
- 여성 : 불응기가 없어 연속적인 절정감 경험 가능

6. 자위행위

- 대상과 관련된 성행위의 정상적인 전단계
- 정신성 발달에 필수적이고 대개 적응 행동의 하나로 나타남 (사춘기 지나면 빈번)
- 성적 역할의 성숙에 도움이 되나, 강박적인 경우 신체쇠약/정신장애/후유증 유발
- 죄책감을 유발하지 않으면 자위는 이후 성적 쾌감을 유지하는데

2절. 성 장애

1. 개요

여성의 성기능장애 : 여성이 성행위를 통하여 만족을 얻지 못하거나 어려움이 있음

- 단일 증상이 아닌 여러가지 형태의 장애가 포함되며 동시에 나타날 수 있음
- 신체적 요인, 심리적 요인, 사회경제적 측면이 있으며 심신의학적 접근이 필요

+) , 여성은 어떠한 기능장애보다는 주관적 욕망(쾌락)에 대한 결핍
남성은 욕망의 결핍보다는 발기, 사정장애 등으로 주로 나타난다

1) 빈도

- ① 1987년[국내] : 여성 54.2%, 남성 33.8% 가 성기능장애
- ② 1999년[미국] : 여성 43% , 남성 31% 가 성기능장애
- ③ 2000년[미국] : 여성 30% 성적흥미부족,
25% 절정감 경험해본 적 없음
20% 질 분비물 감소로 인한 통증과 성관계 부정적 태도
- ④ 2001년[국내] : 성기능장애 유병률 39.8%
그 중 성욕구장애 17.2% 성흥분장애 3.2% 절정감장애 9.4%
- ⑤ 2004년[국내] : 가장 높은 성기능장애 항목 = 성욕저하
- ⑥ 2008년[국내] : 여성 43.5% 가 성기능장애
- ⑦ 2010년[국내] : 성기능장애 유병률 57.5%
- ⑧ 2012년[국내] : 여성 성기능장애 유병률 42.9%, 연령 높아질수록 유병률 증가

2. 분류

1) ICD 성기능장애

- ICD 성기능장애 정의
- 각 개인이 원하는 만큼 성관계를 가질 수 없는 다양한 경우

2) DSM - IV 성기능장애

- DSM- IV 성기능장애 정의

: 기질적 장애나 질병에 의하지 않는 성기능 이상

- DSM- IV 성반응 주기의 각 단계와 관련된 성 기능 장애

: 성욕구장애, 성흥분장애, 절정감장애, 성교통으로 구분

1. 욕구기	• 욕구기 성욕감퇴 장애 • 성적 혐오 장애 • 일반적 의학적 상태에 의한 성욕감퇴 장애 • 욕구장애가 동반된 물질 유도성 성기능장애
2. 흥분기	• 여성 흥분 장애 • 남성 발기 장애 • 일반적 의학적 상태에 의한 남성 발기 상태 • 일반적 의학적 상태에 의한 성교통증 • 흥분 장애가 동반된 물질 유도성 성기능장애
3. 절정기	• 여성 절정감 장애 • 남성 절정감 장애 • 조루증 • 일반적 의학적 상태에 의한 기타 성기능장애 • 절정감 장애 동반된 물질 유도성 성기능장애
4. 해소기	• 성교 후 불쾌감 • 성교 후 두통

3. 주요 유형

1) 성욕 결핍 또는 상실증

- DSM - IV의 성욕 감퇴 장애에 해당
- **성욕의 상실**이 주된 문제이며, 다른 성적인 문제에 의한 2차적인 것은 아님
- 성욕 결핍이 성적 쾌락을 못 느끼는 것은 아니지만 성적 활동의 개시 X
- 일반인구의 20%, 남성 < 여성
- 실제 성행위도 없으며 성적 공상도 없음
- 환자 평가 시 절정기의 문제와 같은 기저의 다른 성적 문제, 주요 우울증과 같은 정신과 적 질병, 만성 소모성 신체질환, 약물 복용의 유무 등을 확인하여야 함

2) 성적 혐오 및 성적 쾌락의 결핍

① 성적 혐오

- 어떤 상대와 성적교류를 예상할 때 강한 거부 감정이 동반되고 두려움이나 불안감

② 성적 쾌락의 결핍

- 성적 반응이 정상적으로 생기고 절정감도 경험하지만 적절한 쾌감이 부족한 것
- 여성에서 흔함

3) 성기 반응 부전

- DSM - IV의 성적 흥분장애에 해당
- 여성의 주된 문제는 **질 건조 또는 윤활부전**으로
lubrication-swelling response가 적절히 이루어지지 않아 성적 흥분을 유지하지 못하는 것
- 질의 윤활이 자위행위나 다른 사람과의 관계에서는 정상적으로 나타난다면 심인성
- 기질적 요인 : 유전질환, 당뇨, 영양장애, 다발성 경화증, 척추손상 등

4) 절정감 부전

- DSM - IV의 절정감 장애에 해당
- 절정감이 생기지 않거나 현저히 지연되는 것
- 주로 **심인성**인 경우가 많음
- 흥분상태에는 도달하나 절정감에 문제가 반복해서 지속적으로 발생
- > 여성의 경우 상대의 기교나 주위의 분위기가 영향을 미치므로 행위 때마다 절정감을 느끼지 못한다고 반드시 성기능장애로 보면 안 됨
- 여성 성 기능 장애 중 가장 많이 호소하는 질환

5) 질 경련증

- 질의 하부 1/3의 근육이 반복적/지속적 경련을 일으켜 음경의 삽입이 불가능하거나 통증을 느낌
- 원인 : 성에 대한 죄책감, 부정적 태도, 반항감, 고통스러운 성행위나 성폭행 경험 한 여성, 고학력의 히스테리성 기질을 가진 여성에서 잘 발생

6) 성교통

- 성행위 직전, 도중 혹은 직후에 다양한 통증을 반복적이고 지속적으로 느낌
- 원인 : 기질적 원인이 흔하므로 철저한 신체적 검사 필요
- 성교통을 주소로 내원하는 여성 환자의 30~40%는 골반 내의 병리 소견을 가짐

7) 성 충동 과다증

- 성욕이 과다하여 자제가 어려운 경우
- 보통 10대 후반이나 성인기 초기에 남녀 모두에게 성욕과다 그 자체를 문제로 호소
- 여성의 경우 nymphomania(여성 색전증)가 해당

8) 기타 성기능 장애

- 9) - 성교 후 두통, 성교 후 불쾌감, 자위동통 등

4. 실험실 검사

① 성 호르몬 검사

- 성기능장애 여성이 외성기위축/질 건조증이 있다면 여성 호르몬의 혈중 농도 측정.

: 난소 절제술 or 다른 내분비질환에 의해 여성호르몬 수치 비정상일 수 있음

- E는 여성 생식기능 유지 뿐 아니라 외음부 및 질의 탄력성, 혈류 유지하는데 중요.

: 폐경기 여성은 음핵의 반응시간이 늦고 질 분비물이 감소하며, 질의 충혈이나 절정감시 근육의 수축기간이 감소

② 기타호르몬 검사

- **프로락틴**은 항-남성호르몬 효과로 성욕장애를 초래할 수 있어 반드시 측정

- 갑상선호르몬 이상으로도 성기능장애 생길 수 있으므로 **갑상선호르몬(T3)** 측정

- 부신질환이 성호르몬 장애를 일으킬 수 있으므로 **부신피질자극호르몬, 코티솔** 측정

5. 치료

- 심인성 성기능 장애 치료법으로 1) dual sex therapy와 2) 정신역동성 치료가 유용

① Dual-sex therapy

- 1970년 성생리 연구결과를 토대로 행동 치료 이론에 기초하여 지도적 성치료 고안

- 치료대상은 부부로, 신체적 검사와 정신 사회적 평가를 함께 시행

- 자세한 면담과 신체 검사를 통해 성기능장애의 원인을 알아내고 관능초점 훈련이라는 전회를 포함한 부부간의 친밀감을 높이기 위한 훈련을 시키고, 증상에 따라 각각 다른 행동요법을 사용

② 정신역동적 치료

- masters와 johnson의 지도적 성치료와 정신분석적 치료 개념을 병용한 kaplan의 치료기법

- 교육과 심리적 지지 + 성감집중훈련/정지-시작법/압축법 탈감작법 등 다양

③ 한방치료

- 다양한 유형의 성기능장애를 허실, 장부, 기혈 등으로 변증하고,

- 변증치료 원칙에 따라 虛한 것은 補하고 鬱滯된 것은 푸는 방법으로 치료

3절. 성교통

1) 정의 : 성교와 관련해 발생하는 생식기의 반복적 통증

2) 한의학 병명 : 交接痛, 合房陰痛, 小戶嫁痛, 吊陰痛

3) 분류 - DSM-IV 분류 : 흥분기장애

- 하지만 부인과 영역의 성교통은 DSM-IV 의 이러한 분류만으로는 충분하지 못해 이와 함께 **기질적 요소에 의한 성교통을 망라한 분류체계가 필요함**

+) DSM-4에서는 기질적이지 않은 성기능장애만 다루는데, 기질적 원인이 성교통의 원인이 되는 사례도 있기 때문

원인질환의 유무에 따른 분류	원발성 성교통	- 다른 원인질환 없이 생김 - 성행위하는 동안에만 나타남
	속발성 성교통	- 다른 원인질환에 속발하여 생김 - 원인 질환에 의한 통증 또는 다른 증상 가질 수 있음
성교통 자각부위에 따른 분류	천부의 성교통	통증이 질이나 질 입구에서 느껴짐
	심부의 성교통	골반내부 또는 하복부에서 느껴짐

4) 특징

- 가장 흔한 성기능 장애의 하나로, 낮은 사회·경제적 계층 여성에게 흔함
- 속발성 성교통이라 할지라도 심리적 요소에 의해 악화와 호전을 경험
- 임상과정에서 신체적 측면, 사회경제적 측면, 심리적 측면을 모두 고려해야 함

5) 진단

- 신체적 이상을 동반한 성교통을 배제하고 기능적인 성교통 또는 원발성 성교통이라 진단하기 위해서는 명확한 기준이 필요하다

※ 기능적인 성교통 혹은 원발성의 성교통의 명확한 진단 기준

① 신체적인 질병에 의한 것이 아닌 독립적 상태

② 윤활액의 부족으로 인하지 않아야 함

③ 기능적인 질경련의 결과가 아니어야 함

-> 이런 기준에 부합되는 경우는 비교적 드물며, 치료 역시 어려운 면이 많음

6) 감별진단

① 성교통과 질경련

동통의 구분	성교통	삽입하는 동안 일반적으로 고통이 있음
	질경련	질과 골반저를 구성하는 근육경련으로 삽입 자체가 불가능

- 서로 관련되어 있으며, 둘 중 하나는 다른 하나의 원인이 될 수 있음

- 만약 질경련이 성교통의 원인이 된다면 일차적인 진단은 질경련이 됨

- 성교통의 유병률은 3~18%로, 폐경 후 여성에게 8~22%로 높게 나타남

- 질경련의 유병률은 1~6%로, 성교통에 비해 상대적으로 낮다

② 성교통과 불감증

- 성교통과 불감증은 종종 같이 나타나지만, 항상 그런 것은 아니다

-> 성교통이 있는 환자에서 절정감을 경험하는 경우도 있고, 절정감을 경험하지 못하나 성교통을 호소하지 않는 경우도 있음

- 성교통이 불감증을 유발할 수도 있고, 불감증이 성교통을 유발하기도 한다.

2. 병인병기

- 전신적 요인, 국소적 요인 모두 성교통을 일으킬 수 있음

1) 천부의 성교통의 신체적 원인

- 외음질염, 요도염, 방광삼각부염, 바르톨린선염 등
- 외음·회음부의 절개술이나 질의 외과적 치료 등 수술 후에 악화되고 수축된 부위
- 고령 여성의 에스트로겐 부족, 외음부의 영양장애
- 젊은 환자의 경직된 처녀막 또는 질의 비정상적 발육
- 성적인 기술에서의 실수, 알리지 반응을 일으키는 피임용 화학제, 여성용 스프레이, 질 관주욕 등도 고려할 수 있는 원인

2) 심부의 성교통의 원인

- 각종 골반 내 병변
: 자궁내막염, 골반염증성질환, 유착, 자궁내막증, 자궁 및 부속기의 종괴 등
- 각종 골반내질환의 치료를 위한 외과적 수술 후 따르는 유착, 반흔
- 난소가 질궁에 봉합된 경우
- 방사선요법, 후굴된 자궁 (= 가장흔한 원인)
- 직장과 요추, 천추 및 골반의 정형외과적인 문제가 통증 유발 가능
- 신체적 원인이 발견되지 않는다면 심인성으로 진단
- 잘못된 성정보, 유년기·청소년기의 잘못된 성경험, 처녀막 상실의 두려움, 성적 배우자에 대한 분노

3) 골반 율혈 증후군

- 원인
: 부적당한 성관계로 만성적인 골반의 율혈이 야기되어 발생하는 것
- 증상
: 성교 후의 골반통, 월경곤란증, 자궁이 증대·민감해지며, 후굴될 수 있음
: 골반부 신체검사에서도 자궁과 부속기의 다른 질환 없이 증대된 자궁이나 현저한 압통을 호소하기도 함
- 특징
: 심신의학적 질환으로, 신체적 요인·심인성 요인 함께 내포
: 성교통은 물론, 다른 골반 저부의 만성 동통들과 밀접한 연관이 있음
: 한의학에서는 골반의 瘀血과 유사

※ 질경련(교과서 X)

- 성교를 할 때나 질 내에 어떤 물체를 삽입할 때 자신의 의사와 관계없이 질 입구쪽 1/3이 수축하여 삽입이 불가능하게 되는 상태
- 원인
 - 심리적인 원인에 의한 것이 많고, 상황에 따라 달리 나타나며, 치료 예후는 좋음
 - 부인과적질환, 만성질환, 약물복용과 관련되면 적절한 치료나 약물복용으로 해결
- 한의학적 병인병기
 - 여러 원인인자들은 간기울결, 간신음허, 혈어, 습열 의 병인병기로 귀납됨
 - 특히 생식기의 기능을 주관하는 肝腎의 기능과 衝任의 기능변조는 주된 병기
 - 陰器를 둘러싸고 있는 간맥이 情志에 의해 자체적으로 율체를 일으키거나 외부의 風寒, 내부적인 陰寒의 응축, 氣血陰精의 부족으로 구급하여 발생

3. 진단과 감별진단

1) 진단

아래 항목들에 대해 상세한 문진과 검진을 시행

- 통증 소재 : 통증 발현시기, 지속성, 자각부위(深淺)
- 통증 양상 : 刺痛, 乾澁을 동반한 동통 유무
- 정신적 발달과정 포함한 사회력, 기타 병력청취
- 부인과 검진 : 외음부, 질의 병적 분비물, 염증, 조직 손상, 위축, 해부학적이 상여부
- 내분비 검사, 골반염증성질환 감별 검사, 자궁 내막증 감별검사
- 심리검사, 정신과적 검사

2) 감별진단

-질경련, 陰痛, 직장의 병변, 정형외과적 요인과 감별

+) 성교통은 음통과 유사하나 성교와 관련된 상황에서만 제한적 발생

4. 변증치료

1) 허실한열에 따른 분류

허실	허	간신음허 충임휴손 요슬산연 신피체권 성욕감퇴 두훈이명 설질담홍
	실	간기울결, 울구화화, 습열하주, 충임어조 홍협소복창통 변조이노 맥현혹맥현삭
한열	한	양기부족, 충임허손
	열	음허 , 양성

2) 한의학적 변증

간기울결	성교통, 정신문제, 소복양측, 하지내측으로 통증, 유방통증, 홍협창통, 두통, 목현	
	소간해울 이기통락지통	천련자산(川楝子散)가감
충임휴손	성교통, 성욕감퇴, 요슬산연, 월경 불규칙, 외음부 위축, 유방 탄력성 저하	
	보익충임	귀녹이선고(龜鹿二仙膏)가미 = 이선탕(음양곽 선령비)
충임어조	성교통은 찌르는 듯 자각, 소복창통, 월경량 적음	
	활혈지통 조리충임(調理衝任)	사물탕 합 실소산 가 천련자 소회향
간신음허	성교통, 음부건조, 질내작열통, 요산, 도한, 현훈, 이명, 피로, 오심번열, 안면홍조	
	자보간신 전정윤조지통 (填精潤燥止痛)	지백지황환 합 이지환(二至丸) 가미 = 여정자, 한련초
간담습열	성교시 질내 작열통, 대하 양이 많고, 황색이며 냄새 남, 소복통, 불면, 홍협창통, 요도작열	
	청사간담습열	용담사간탕 가감

※ 참고) 질경련의 변증치료

- ①간기울결형 - 소간해울, 행기완급지통 ➡ 사역산 가감
- ②신음부족형 - 자신육음, 유윤지경 ➡ 좌귀환 가감
- ③충임허손형 - 온보충임, 전충지경 ➡ 구녹보충탕 가감
- ④간담습열형 - 청화습열, 행체지경 ➡ 경험방

4절. 성욕 감퇴증

1. 개술

- 정의
 - 일정 기간 성적 욕구가 저하되거나 완전히 결핍되어 성적 공상과 성행위 능력이 모두 저하된 것
- DSM-IV 분류
 - **욕구기의 성욕 감퇴 장애**
- 빈도
 - 결혼한 여성의 30%, 여성이 남성보다 2배 이상
- 예후
 - 욕구기 성기능 장애 환자는 흥분기/절정기 성기능장애보다 예후가 좋지 않음
- 치료원칙
 - 억제된 성적공상의 개방과 계발을 모색, 신체적 허약이나 질환 치료
 - 한의학에서는 陰冷 치료 참고가능

2. 병인병기

1) 원인

- 절대 다수가 정신 심리적 요소가 원인
- 성지식 결핍, 성생활 부조화, 성교 전 성욕 극대화의 결핍, 남성조루, 난폭 성행위
- 다른 성기능 장애가 있다면 유발가능
- 평소에 전신질환, 만성 질병이 있으면 성욕 감퇴를 일으킬 수 있음
 - : 신경·내분비 계통 기능에 영향을 미쳐 혈중 성호르몬 수준 저하, 성적욕구 억제
- 일부 고혈압 치료제, 경구 피임약, 항정신병 약물로도 속발될 수 있음

2) 한의학적 병인병기

- 심, 간, 비, 신 및 奇經의 상관관계로 인식
- 신양허쇠, 간기울결, 심비양허, 간혈부족, 심담허겁

3. 진단

1) 진단

- 결혼 또는 정기적 성 관계를 지속한 후 3개월 이상 여성의 주동적인 성 요구가 없거나 성적 공상이 결여된 상태가 지속되고,
- 성행위를 할 때 성적인 정동의 표현이 미약하거나 없는 경우 진단

2) 감별진단

① 절정감 장애

- 절정감 장애는 여성의 성욕은 정상이거나 강하나 성교 과정 중 절정감을 자각하지 못하거나 매우 미약한 경우에 해당

② 성적 혐오 장애

- 성적 혐오 장애는 성 활동에 대한 혐오감이 지속되는 반응으로,
- 성적 접촉이 있을 때 발생할 뿐만 아니라 성에 대한 전반적인 부정적 견해가 충만한 반응

4. 변증치료

신양허쇠	성욕감퇴, 소복냉, 요슬산연, 형한지냉, 흰 색의 땀은 대하	
	보신장양 溫補命火	우귀환 가감
간기울결	성욕감퇴, 정신불안, 흥협창만, 불안번조, 월경부조	
	소간해울	소요산 가감
심비양허	성욕감퇴, 식욕저하, 경계, 불면, 피로, 월경량 감소	
	보익심비	귀비탕 가미
간혈부족	성욕감퇴, 안구건조, 월경량 감소, 두훈, 목현, 사지마목, 다몽, 흥협통, 우울	
	보양간혈	보간탕 가미
심담허겁	성욕감퇴, 경계, 善驚, 불면, 다몽, 불안성	
	양심안신 익담정혼(益膽定魂)	평보진심단 (平補鎮心丹) 가감

제5절. 절정감장애

1. 개술

1) 정의

- 성욕의 수준이 정상적이거나 비교적 강하지만 성교과정 중 극치감이 나타나지 않거나 현저히 부족해 성적 만족에 이르지 못하는 것
- 불감증, 성 고조 장애 등으로 불림

2) 분류

Masters&Johnson에 따른 분류

원발성	임의의 어떠한 성적 조건과 환경에서도 절정감에 이르지 못하는 것
속발성	과거 특정 어느 시기에는 절정감에 도달했으나 현재는 도달하지 못하는 것
환경성	특정 상황 하에서는 한번 혹은 여러 번 절정감에 도달할 수 있는 것
성교성	정상적인 성교에서는 도달 못하나 수음이나 다른 자극을 통해서 도달하는 것

3) 빈도

- 여성의 약 5~10% 정도에서 원발성 절정감 장애
- 원발성 절정감 장애가 속발성 절정감 장애보다 흔함
- 속발성 절정감장애는 배우자와의 관계, 우울, 약물남용, 특정약물 투여, 당뇨병과 같은 만성적 질병, 에스트로겐 부족, 다발성 경화증과 같은 신경 계통의 질병으로 생길 수 있음
- 절정감 장애를 가진 환자들이 냉감, 우울감, 골반부 통증 등 우회적으로 표현하는 경우가 많음

2. 병인 병기

1) 원인

- 절정감장애의 원인은 정신적 요인과 신체적 요인으로 나뉨

① 정신적 요인

- 90% 이상으로, 가장 흔함
- 가장 흔한 정신적 원인 : 자신의 의식과 행동에 대한 강박관념적인 주목
성적인 자극이 이루어지는 단계에서의 자기암시
- 성기능이상을 가진 여성은 그녀 자신과 성적 배우자의 반응을 주목하는데 바쁘고, 대개 실패에 대해 너무 걱정을 많이해서 성적 자극을 자신의 반사적 능력과 절정감으로 연결할 수 없는 경우가 많음
- Masters와 Johnson은 이러한 행동불안을 가진 사람을 '방관자'라 부름

② 신체적 요인

골반신경의 손상	다발성 경화증, 척수 손상, 종양, 당뇨병성 신경병변
음핵 및 질의 혈액순환장애	복부동맥류, 혈전성 폐색, 동맥염, 동맥경화
내분비질환	뇌하수체기능부전, 당뇨병, 갑상샘과다 및 저하증
만성질환	
부인과적 요인	부인과적 수술, 생식기 감염, 선천성 기형

2)한의학적 병기

- 신, 간, 심 및 寄經의 기능이상과 관련

• 腎 : 선천의 근본 , 안으로는 진음/진양을 藏하여 인체의 생장, 발육, 생식의 원천

• 肝 : 모든 정신정지의 조절

• 心 : 神明을 주관

3. 진단: 주로 병력청취에 의거하여 진단.

- 정신적 성숙, 사회 심리적 문제, 성생활,

- 원발성 절정감 장애를 치료하기 위해 가장 기본적인 고 유효한 것은 자위행위를 통한 성감의 학습

- 자극적인 기구, 약물의 장기간 사용은 적절치 않음

4, 치료

1) 한의학적 병인

명문화쇠	성욕 있으나 절정감에 도달X, 질 분비물 감소, 소복냉, 요슬산연, 피로, 과소월경	
	온보명화(溫補命火) 배원고본(培元固本)	우귀환 가감
신정부족	성욕 강하나 절정감에 도달X, 질 건조감, 오심번열, 피부건조, 도한, 요슬산연, 월경량 감소, 현훈, 이명	
	자신전정(滋腎填精) 양음강화(養陰降火)	좌귀환 가감
간기울결	절정감에 도달X, 정서적 긴장, 번조이노, 가슴답답, 월경부조, 홍혈부 불편감	
	소간해울	소요산
심비양허	절정감에 도달X, 피로, 경계, 수면장애, 식욕부진, 월경량 감소, 안색저하	
	보익심비 양신계쾌(養神啓快)	귀비탕 가미
심신불교	절정감 불확실, 안색 누렇다, 질 분비액 적음, 현훈, 불면, 수족장열, 요슬무력	
	교통심신(交通心腎) 수화상제	육미지황환 합 주사안신환 or 청심연자음

2) 변증치료

-한열허실에 따른 변별

실증	대부분 간기울결로 인함
허증	대부분 신의 음양과 충임의 허손으로 인함